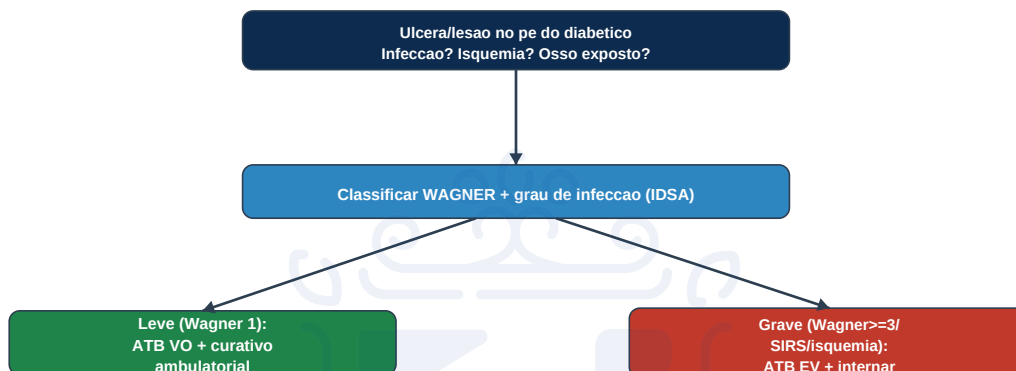


PÉ DIABÉTICO — INFECÇÃO, ISQUEMIA E GLICEMIA

FLUXOGRAMA — AVALIAÇÃO NO PS

PÉ DIABÉTICO — GRAVIDADE DEFINE O DESTINO



QUANDO SUSPEITAR — ANAMNESE

PERGUNTAS-CHAVE

- Sente dor na ferida? (NÃO = neuropatia grave — lesão indolor)
- Tem pus ou mau cheiro saindo da ferida? (infecção)
- Teve febre/calafrios em casa? (infecção sistêmica)
- Pés sempre frios, claudicação, feridas que não cicatrizam? (isquemia)
- Já teve úlcera/amputação antes? Último controle glicêmico (HbA1c)?

EXAME FÍSICO ESSENCIAL

INSPEÇÃO + PALPAÇÃO + NEURO

- Úlcera: localização (plantar=neuropática, bordas/dedos=isquêmica), tamanho, profundidade, base, secreção
- Pulsos pedioso e tibial posterior (OBRIGATÓRIO, comparar bilateralmente); temperatura (quente=infecção, frio=isquemia)
- Probe-to-bone: tocar osso na base da úlcera = OSTEOMIELOITE (sensibilidade ~87%)
- CREPITAÇÃO subcutânea = fasciite necrosante/gangrena gasosa = EMERGÊNCIA cirúrgica
- Neuro: monofilamento 10g (3 pontos), diapasão 128 Hz no hálux, reflexo aquileu

Suporte ao Plantão Médico

CLASSIFICAÇÃO DE WAGNER

Grau	Características	Conduta
0	Pé de risco (calosidade, deformidade), sem úlcera	Orientação, calçado adequado
1	Úlcera superficial não infectada	Curativo, descarga, ambulatorial
2	Úlcera profunda (tendão/articulação) sem abscesso/osteomielite	ATB VO, avaliar internação
3	Úlcera profunda COM abscesso, osteomielite ou celulite	ATB EV + INTERNAÇÃO
4	Gangrena localizada (dedos/calcanhar)	ATB EV + cirurgia vascular
5	Gangrena extensa do pé	Amputação

RED FLAGS — INTERNAÇÃO IMEDIATA

INFECÇÃO GRAVE / ISQUEMIA CRÍTICA

- Sinais sistêmicos: febre > 38, taquicardia, hipotensão, confusão (sepsis)
- Celulite extensa (eritema > 2 cm), linfangite ascendente, secreção purulenta abundante
- CREPITAÇÃO subcutânea (fasciíte/gangrena gasosa) = EMERGÊNCIA cirúrgica (desbridamento)
- Necrose/gangrena; osteomielite (osso exposto/probe-to-bone +); abscesso profundo
- Isquemia crítica: pulsos ausentes + lesão que não cicatriza, dor em repouso, ITB < 0,5

ANTIBIOTICOTERAPIA POR GRAVIDADE (IDSA/IWGDF)

Gravidade	Esquema	Local
Leve (eritema <2cm)	Cefalexina 500mg VO 6/6h OU Amoxi-clav 875/125mg VO 12/12h (7-14d)	Ambulatorial
Moderada	Amoxi-clav 875/125 VO 12/12h (alergia: Levofloxacino + Clindamicina) 14d	Internar se comorbidade
Grave (SIRS/isquemia)	Ampi-sulbactam 3g EV 6/6h OU Pipe-tazo 4,5g EV 8/8h OU Ceftriaxona + Metronidazol	INTERNAÇÃO
MRSA / Pseudomonas	Add Vancomicina 1g EV 12/12h / usar Pipe-tazo ou Cefepime 2g EV 8/8h	INTERNAÇÃO

CONTROLE GLICÊMICO E CURATIVO

Rx

CONTROLE GLICÊMICO

Meta no PS: glicemia 140-180 mg/dL
Se > 250: insulina regular 8-10 UI SC (repetir em 2-4h se > 250)
Hidratação SF 0,9% 500-1000 mL
Avaliar cetoacidose se > 300 + cetonúria/acidose -> protocolo CAD
Encaminhar para ajuste com endocrinologia

Rx

CUIDADOS LOCAIS

Lavar com SF 0,9% abundante (jato suave)
Desbridar necrose/esfacelo/calosidade se viável no PS
NÃO usar iodopovidona, água oxigenada, permanganato (citotóxicos)
Infetada: sulfadiazina de prata / carvão com prata
Necrose SECA (escara): manter seca até avaliação vascular — NÃO desbridar no PS

EXAMES

SOLICITAR

- Todos: HGT, hemograma, PCR, ureia/creatinina, Na/K, HbA1c
- Se infecção mod/grave: hemoculturas (2) antes do ATB, cultura profunda da ferida, gaso/lactato
- RX do pé (AP/perfil/oblíquo): Wagner ≥ 2 ou suspeita de osteomielite (osteólise, gás nos tecidos)
- RM = padrão-ouro para osteomielite (fora do PS); Doppler/ITB se ausência de pulsos (ITB $< 0,9$ = DAP)

ALTA E ORIENTAÇÕES

ALTA SE (infecção leve)

- ☐ Celulite < 2 cm sem sinais sistêmicos; glicemia controlada (< 250); pulsos presentes/isquemia leve
- ☐ Capacidade de curativo em casa/UBS e seguimento garantido (vascular, endócrino, curativo)
- ☐ Orientar: inspeção diária dos pés, calçado adequado, nunca andar descalço, não usar esalda-pés/bolsa quente
- ☐ Cortar unhas retas; hidratar a pele (exceto entre os dedos)
- ☐ Retorno IMEDIATO: febre, piora do eritema, pus/odor, escurecimento dos dedos, dor intensa, crepitação

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente diabético, pé diabético Wagner ____; úlcera em ____, ____ cm, profundidade ____; infectada: sim/não.
- Pulsos: presentes/ausentes; probe-to-bone: +/-; febre/leucocitose/PCR ____; glicemia ____.
- ATB iniciado (EV/VO): ____; RX do pé: ____.
- Necessita internação para ____ (ATB EV / desbridamento / amputação / avaliação vascular / controle glicêmico).

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Diabético com úlcera plantar profunda, crepitação subcutânea e secreção fétida, febril e hipotenso. Qual a conduta prioritária?

- A) Antibiótico oral e alta com retorno em 7 dias
- B) Internação + antibiótico EV de amplo espectro + desbridamento cirúrgico URGENTE (suspeita de fasciite/gangrena gasosa)
- C) Apenas curativo com sulfadiazina e observação
- D) Aguardar cultura antes de qualquer medida
- E) Encaminhamento ambulatorial à endocrinologia

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

No exame da úlcera, ao tocar o fundo com swab estéril percebe-se contato ósseo. O que isso sugere?

- A) Neuropatia
- B) Osteomielite (probe-to-bone positivo)
- C) Isquemia crítica
- D) Celulite leve
- E) Úlcera venosa

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual a meta glicêmica no PS para o paciente com pé diabético infectado?

- A) 80-110 mg/dL
- B) 140-180 mg/dL
- C) 200-250 mg/dL
- D) Menor que 70 mg/dL
- E) Acima de 300 mg/dL

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual produto NÃO deve ser usado no leito da úlcera por ser citotóxico?

- A) Soro fisiológico 0,9%
- B) Iodopovidona / água oxigenada / permanganato
- C) Alginato de cálcio
- D) Hidrogel
- E) Sulfadiazina de prata

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Pé diabético Wagner grau 3 (úlcera profunda com osteomielite). Qual a conduta?

- A) Antibiótico oral por 7 dias e alta
- B) Antibioticoterapia endovenosa e internação (osteomielite exige ATB prolongado)
- C) Apenas curativo ambulatorial
- D) Observação sem antibiótico
- E) Amputação imediata em todos os casos

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Crepitação subcutânea + secreção fétida + sepse sugere fasciite necrosante/gangrena gasosa — emergência cirúrgica. Conduta: internar, ATB EV de amplo espectro e desbridamento cirúrgico urgente; não aguardar cultura.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O teste probe-to-bone positivo (contato ósseo no fundo da úlcera) tem alta sensibilidade (~87%) para osteomielite, que muda o tratamento (ATB prolongado 4-6 semanas e avaliação cirúrgica).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A meta glicêmica no PS para o pé diabético infectado é 140-180 mg/dL; controle adequado favorece a resposta à infecção e a cicatrização, sem o risco da hipoglicemia de metas muito rígidas.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Iodopovidona, água oxigenada e permanganato são citotóxicos e prejudicam a granulação. Limpa-se com SF 0,9%; cobre-se conforme o leito (alginato/hidrogel se limpa; prata se infectada).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Wagner 3 (úlcera profunda com osteomielite/abscesso/celulite) requer internação e antibioticoterapia EV; a osteomielite demanda tratamento prolongado (4-6 semanas) e avaliação cirúrgica, não apenas ATB oral.

SM24
Suporte ao Plantão Médico